

CONSTRUIDO EN MIDNIGHT

Demuestra que calificás. No revelás nada.

Adepe convierte un historial médico firmado por un hospital en una prueba de conocimiento cero de elegibilidad para ensayos. El paciente encuentra el estudio. El patrocinador obtiene un inscrito pre-calificado. Nadie obtiene el historial.

Un desarrollo clínico puede durar una década.

FASE 1 Dosis y seguridad	FASE 2A Prueba de concepto	FASE 2B Dosis definitiva 100–300 pacientes	FASE 3 Significancia estadística 300–3.000 pacientes	FASE 4 Farmacovigilancia
---	---	--	--	---

Fases 1–3: perdés plata. El reclutamiento y la retención representan aproximadamente un tercio del costo, y el contador corre haya o no inscriptos.	Fase 4: riqueza generacional. Cada mes que llegás tarde es un mes de vida de patente gastado en un fármaco no aprobado.
---	---

La inscripción está rota en ambos lados de la mesa.

LADO DEL PATROCINADOR

~30%

de los pacientes evaluados no superan la elegibilidad. En oncología, cerca del 40%.

- La Fase 2b necesita 100–300 pacientes; la Fase 3, 300–3.000
- Aproximadamente 8 de cada 10 ensayos no cumplen su cronograma de inscripción
- Se activan sitios que nunca inscriben un solo paciente

LADO DEL PACIENTE

0

formas de buscar un ensayo sin entregarle tu diagnóstico a un desconocido.

- Gasto de bolsillo y días de trabajo perdidos por una evaluación que falla
- El estrés de perseguir estudios estando enfermo
- Historial oncológico divulgado a cada patrocinador al que te acercás

INVERTIMOS EL JUEGO

HOY **Hospital → busca → paciente**

ADEPE **Paciente → busca → estudio**

Cuando busca el patrocinador, cada candidato comparte su historial para ser considerado. Cuando busca el paciente, solo se comparte un proof. El mismo resultado sin tener que exponerse.

Cuatro pasos, una prueba.

01 El hospital firma Un proveedor registrado firma con Schnorr el historial médico y se lo entrega al paciente. En la cadena, solo se registra la clave pública del proveedor.	02 El paciente guarda El registro firmado vive en la billetera del paciente como testigo. Nunca se sube, nunca se pone en custodia, nunca se envía a un patrocinador.	03 El circuito verifica <code>Verify(trialID)</code> valida la firma, confirma que el firmante es un proveedor registrado y compara el registro con los criterios del ensayo, todo dentro de la prueba.	04 El seudónimo se inscribe Una clave específica del ensayo, derivada del secreto del paciente y el ID del ensayo, se suma al conjunto elegible. El patrocinador ve un inscrito calificado y puede invitarlo.
--	---	---	---

La clave de inscripción mezcla el ID del ensayo a propósito: un paciente elegible para cuatro estudios aparece como cuatro claves sin relación, de modo que nadie puede unir los conjuntos públicos para reconstruir el historial de ensayos de una persona. Volver a probar es idempotente.

El límite de divulgación, exactamente.

PÚBLICO EN MIDNIGHT

- trialID al que se aplica
- los criterios del ensayo, fijados al crearlo
- claves públicas de proveedores registrados
- un seudónimo de inscripción por ensayo

NUNCA SALE DEL PACIENTE

- edad
- cirujías
- antecedentes
- enfermedades autoinmunes
- comorbilidades
- qué hospital firmó el registro

Una verificación fallida no escribe nada: un paciente inelegible es indistinguible de uno que nunca se postuló.

El reclutamiento es un tercio del costo de un ensayo.

\$6.533

costo por paciente inscrito en reclutamiento y
retención

8 de 10

ensayos no cumplen su cronograma de
inscripción

~30%

de los pacientes evaluados no superan la
elegibilidad; en oncología, cerca del 40%

Fuente: Tufts CSDD, datos de enrollment publicados.

PARA PROFUNDIZAR

Qué más se puede hacer con Midnight ZK?

CRITERIOS MÁS RICOS

Valores de laboratorio, estadificación y líneas previas de tratamiento son campos adicionales en el mismo circuito Compact. La prueba escala sin cambiar el contrato.

CREDENCIALES REUTILIZABLES

El registro firmado por el hospital puede probarse ante múltiples estudios con pseudónimos independientes. Un paciente nunca vincula sus aplicaciones entre sí.

RED DE CONFIANZA

El registro on-chain puede conectarse a listas nacionales de acreditación: una firma vale legalmente sin revelar qué institución emitió el registro.

Adepe: el paciente busca, y se queda con el historial.